七、全部小结

（一）可能可能最可能

高血脂尤其胆固醇、高血压、吸烟、糖尿病等病史，胸骨后压榨性痛、可放射至颈部/左肩/左臂、伴大汗

病例题逻辑：说了一大堆都舍不得说胸痛、为什么要先考虑冠心病呢？（但不能排除冠心病）

①阳间病例题谁最可能就选谁、不要总想着排除什么

②阴间病例题比较谁最不像

（1）心绞痛

胸痛多＜30 分钟、心肌坏死标志物正常

夜间痛	有	**ST 段抬高**→变异型心绞痛 冠脉完全闭塞，心肌全层/透壁缺血损伤	
		静息型心绞痛 ST段压低	
	无	发作频率低，程度、持续时间等**数个月内无明显变化**→稳定型心绞痛 斑块稳定"皮厚馅少"	
		发作频率高（1 个月来反复出现）	恶化型：**先诊断稳定型心绞痛**
			初发型

（2）急性心梗

①多休息发作、**持续数小时**、**心肌坏死标志物↑**（红 2 钙 3 酸 4），ST 段弓背向上**抬高+病理 Q 波**（STEMI）、或 ST 段**压低≥0.1mv**（NSTEMI）　肌钙蛋白3-4小时后才会增高

患者出现胸痛2小时，肌钙蛋白阴性，心电图ST段压低≥0.1mv，没有病理Q，该患者最可能诊断？

不会优先考虑心绞痛　非ST段抬高型心肌梗死

②急性心梗并发

乳头肌功能失调或断裂 抗缺血治疗后好转	心尖收缩期杂音（二闭）、心尖收缩中晚期喀喇音（二脱） 急性左心衰（乳头肌断裂，二尖瓣后乳头肌断裂多见于下壁心梗）
室壁瘤	超声心动图反常搏动/矛盾运动、心电图 ST 段持续抬高 持续损伤
心室游离壁破裂	急性心脏压塞、无脉性电活动
室间隔破裂	胸骨左缘 3-4 肋间收缩期杂音
心梗后/Dressler 综合征	数周-数月出现心包炎（心包摩擦音）、胸膜炎、肺炎

（二）治疗小结

1.血运重建（PCI 和 CABG）为 **ACS 的最佳治疗**　不是稳定型心绞痛的最佳治疗(在规范药物治疗后无效才考虑血运重建)，是急性冠脉综合征的最佳治疗(不稳定型心绞痛、心肌梗死)

若**心源性休克先主动脉内球囊反搏** IABP 过渡争取再灌注治疗时间（急性**右**室梗死**补充血容量**）

右室梗死的首要治疗:补液;左室梗死的首要治疗:PCI。二者根本治疗都是PCI

2.药物（注意禁忌症）　禁忌症:2234都积极笑,变异咯

	硝酸酯类（不能改善预后）	β-R 拮抗剂	CCB 长效	**抗板**	抗凝	溶栓
稳定型心绞痛	√	√	√	√	×	×
UA/NSTEMI	√	√	√	√	√	× 白色血栓
变异型心绞痛	√	×加重痉挛	√**首选**	√	√	×
STEMI	√	√	× 负性肌力	√	√	√ 关注禁忌症
急性右室梗死	×	√	× 负性肌力	√	√	√

禁用一切减少回心血量的药物

β-R拮抗剂对于左室梗死更有价值,因为从心律失常角度,左室梗死更容易出现恶性心律失常,而右室梗死更容易出现缓慢性心律失常和低血压休克(β-R拮抗剂禁忌症)